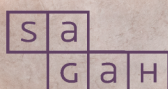


GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Janete Arcari



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Indicadores de qualidade e produtividade dos serviços de saúde

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Descrever a importância dos indicadores de qualidade e produtividade para a tomada de decisão.
- Identificar a validade e a confiabilidade de indicadores em serviços de saúde.
- Apresentar alguns indicadores padronizados que auxiliam na comparação de qualidade *versus* produtividade.

Introdução

Os indicadores são aliados importantes e podem proporcionar aos gestores de organizações de saúde informações capazes de auxiliar no processo de tomada de decisão. Para que os indicadores sejam viáveis e práticos, devem apresentar alguns atributos especiais. Na perspectiva teórica, os indicadores de qualidade e produtividade podem ser abordados separadamente, mas, na prática, existe um campo de interação entre eles que possibilita a visão de desempenho da instituição.

Neste capítulo, portanto, você vai conhecer os principais atributos de um bom indicador e alguns exemplos de indicadores de qualidade e produtividade para os serviços de saúde. Para isso, você vai ver a relevância da aplicação de indicadores de qualidade e produtividade na área de saúde e suas contribuições para garantir a eficiência e a melhoria da qualidade no setor, aprimorar os processos e melhorar o atendimento das necessidades dos clientes/usuários.

1 O uso de indicadores de qualidade e produtividade

O termo indicador vem de indicar, mostrar, denotar, apontar. Um indicador, portanto, é um dispositivo ou sinal que serve para evidenciar um fenômeno. Mais especificamente, os indicadores podem ser conceituados como mecanismos de avaliação em bases mensuráveis, isto é, modelos simplificados da realidade com a capacidade de facilitar a entendimento dos fenômenos/ eventos, de modo a aumentar a capacidade de comunicação de dados brutos e de adaptar as informações aos interesses dos diferentes atores envolvidos. Além disso, são representados por números e devem incorporar respostas de ações estruturadas com propósitos bem definidos (DAMASCENO, DAMASCENO, BARROS, 2008).

Os indicadores, independentemente de sua categoria, são instrumentos importantes, pois trazem à luz o que a instituição precisa ver para melhorar seus processos e conseguir um suporte para alinhá-los às metas traçadas (BARBOSA; MELO, 2008). Nesse sentido, cabe ressaltar que um indicador é constituído de um conjunto de dados ou variáveis, submetidos a operações estatísticas, revelando informações referentes a um determinado fenômeno ou evento.

Outro fator de extrema importância é monitorar o indicador, o que permite avaliar ao longo do caminho se o que estamos fazendo está funcionando ou não, descobrir os pontos que podem ser melhorados para otimizar o processo e, assim, fazer as correções necessárias durante o percurso, aumentando a eficácia dos serviços.

Uma das características que colaboram para a utilização dos indicadores é a capacidade de simplificar informações relevantes e facilitar a comunicação entre os diferentes interessados. A tomada de decisão deve ser embasada em elementos concretos, o que torna os indicadores ferramentas fundamentais nos processos de gestão e planejamento e, para a sociedade, representam instrumentos importantes para o controle social.

A busca pela qualidade do atendimento na área de saúde ocorre tanto em instituições privadas quanto nos serviços públicos de saúde — am-

buscam continuamente por instrumentos capazes de proporcionar o aumento da qualidade e da produtividade com objetivo de oferecer aos usuários condições dignas de atendimento. Se analisarmos em especial o setor público, em que a demanda por atendimentos é maior que a oferta dos serviços prestados, torna-se fundamental a criação de normas e mecanismos de avaliação e controle da qualidade para otimização dos processos e melhoria no atendimento.

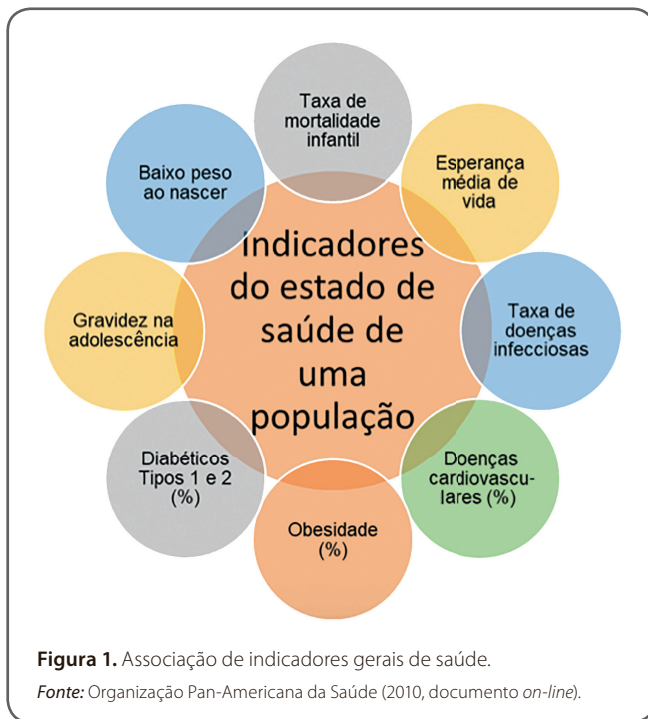
Portanto, é necessário medir frequentemente os resultados para obter dados precisos e concretos da atual situação, sendo importante demonstrar fatos, conceituar produtividade em saúde e embasar as reivindicações de melhoria contínua da qualidade (ROSSANEIS *et al.*, 2014).

Embora os processos de trabalho nas instituições de saúde tenham passado por mudanças com avanços científicos e tecnológicos, ainda se fala em necessidade de atendimento humanizado, filas de espera, infecção hospitalar com índices elevados, ineficiência da gestão de custos, ausência de educação continuada, educação permanente insuficiente, quadro de pessoal inadequado/escasso, entre outras dificuldades.

Essa conjuntura requer, dentre outros fatores, modelos de gestão adequados e que consigam otimizar os recursos aplicados, inclusive por força de uma legislação mais rigorosa. Além disso, exige melhora na produtividade e ampliação do nível de satisfação não somente dos usuários, mas também dos profissionais que atuam nos serviços de saúde (ROCHA; TREVIZAN, 2009). Assim, os indicadores podem ser classificados como demográficos, socioeconômicos, de saúde, recursos, acesso e cobertura.

Utilizados internacionalmente, os indicadores de saúde são parâmetros para a avaliação da saúde da população e fornecem dados para o planejamento de saúde, permitindo o acompanhamento das tendências históricas do padrão sanitário de diferentes populações consideradas à mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo (TANAKA; TAMAKI, 2012).

Veja, na Figura 1, um exemplo de esquema dos indicadores do estado de saúde de uma população.



Fique atento

Você sabia que a taxa de mortalidade infantil vem diminuindo no Brasil? A taxa de mortalidade infantil (TMI) é calculada com base no número de óbitos de crianças com até um ano de idade para cada 1000 mil crianças nascidas vivas. Esse indicador tem conexão direta com as condições socioeconômicas do território que habitam e retrata a qualidade da saúde da população. É o indicador significativo para avaliar o desenvolvimento e as desigualdades sociais de determinada população (ANDRADE *et al.*, 2006).

O cálculo se dá pela equação:

$$\frac{\text{Nº de óbitos de residentes com menos de um ano de idade} \times 1000}{\text{Nº de nascidos vivos de mães residentes}}$$

É importante destacar que, em 2010, a TMI era 17,22; para 2020, a previsão é de 11,56 e, para 2030, espera-se alcançar 9,01.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([2018], documento on-line).

2 Qualidade dos indicadores

Os indicadores auxiliam os gestores na identificação dos pontos fortes e fracos de sua instituição e são qualificados para determinar o perfil e influenciar os valores das organizações. Além disso, podem ser classificados em indicadores de processo e de resultado. Os primeiros possibilitam revelar iniciativas da organização quanto ao processo, e os de resultado retratam a obtenção dos objetivos estratégicos. Veja, a seguir, segundo a Rede Interagencial de Informação para a Saúde (2008), alguns atributos importantes e que devem ser considerados na escolha de um indicador:

- deve ser de fácil entendimento e percepção;
- deve ter uniformidade;
- deve atingir o maior número possível de variáveis;
- permite comparações entre situações;
- deve ser principalmente confiável;
- é importante que sejam respeitados os aspectos éticos.

Ao se escolher um indicador para trabalhar, portanto, é de suma importância preocupar-se com três fatores fundamentais:

- sua eficiência (custo e benefício);
- sua eficácia (obtenção dos objetivos propostos);
- sua efetividade (resultados).

Os dados obtidos são representados por meio de frequência absoluta (números ou fatos) ou de frequência relativa (índice, coeficientes ou taxas) (MERCHÁN-HAMANN; TAUILL; COSTA, 2000).

- **Índice:** sinal de que há uma relação de proximidade com o representado — é a relação entre dois números ou a razão entre determinados valores.
- **Taxa/coeficiente:** é a relação entre o número de casos de um evento e uma determinada população em um dado local e época. É a medida que informa quanto ao “risco” de ocorrência de um evento.
- **Números absolutos:** podem ser indicadores, à medida que se comparam valores iguais, maiores ou menores a ele, resultantes de atividades.
- **Fatos:** demonstram a ocorrência de um resultado benéfico ou não, como, por exemplo, uma reação alérgica.



Exemplo

Um exemplo de indicador amplamente utilizado é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que engloba três grandezas de medida do desenvolvimento humano: vida longa e saudável, obtido por intermédio do indicador esperança de vida ao nascer; oportunidade de educação; e nível de vida digna, aferido pelo indicador Produto Interno Bruto (PIB) *per capita*.

A agregação desses indicadores sintetiza resultados para cada país, com valores previamente estabelecidos, apontando, por meio das referências de valores, a posição de cada país: alto (entre 0,8 e 1), médio (entre 0,5 e 0,79) e baixo (menor que 0,49) (MARTINS; PONTES; HIGA, 2018).

Indicadores de qualidade e produtividade na área da saúde

Os indicadores são muito mais do que o conjunto de dados em que estão baseados: adicionam valores aos dados, transformando-os em informações úteis para os gestores e tomadores de decisões de diferentes áreas, assim como para a sociedade como um todo.

No âmbito da gestão, a profissionalização passa pela implementação de indicadores, dentre eles, os de qualidade e de produtividade, que variam conforme o tipo de serviço que se quer avaliar. No contexto da humanização do atendimento na área de saúde, os avanços em qualidade e produtividade são primordiais para sincronizar a oferta com a demanda, e não somente para o setor privado, mas, em especial, para o setor público, ao oferecer à população condições mais dignas na prestação de serviços de qualidade.

Os indicadores de qualidade e produtividade vêm sendo utilizados cada vez mais nas organizações de saúde como ferramenta para reduzir custos, aumentar os lucros, aperfeiçoar os processos e melhorar o atendimento das necessidades dos usuários/clientes.

Outro fator importante com relação aos indicadores de qualidade e quantidade em serviços de saúde é o crescimento progressivo dos gastos no setor da saúde, principalmente nos hospitais, decorrente dos avanços tecnológicos e do aumento da complexidade assistencial, demandando dos gestores o enfrentamento de desafios constantes para a viabilização dessas instituições na oferta de serviços (BONACIM; ARAÚJO, 2011).

Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é fundamental para planejamento, organização, coordenação/gestão e avaliação/controlar as ações realizadas que tenham como finalidade a medição dos resultados, processos e da estrutura necessária ou utilizada, bem como a repercussão social.

Especialmente no setor privado de saúde, o aumento da concorrência estimulou a utilização de melhores práticas e procedimentos em atendimento às exigências dos clientes/usuários. Assim, de acordo com Damasceno, Damasceno e Barros (2008), a utilização de indicadores de qualidade e produtividade contribui para apontar as reais deficiências do setor e para a análise necessária às ações que têm como objetivo melhorias nos processos de serviços.

3 Qualificação de indicadores de qualidade e produtividade na área da saúde

Embora um indicador não seja uma medida direta de qualidade, é um indicativo no sentido de direcionar a atenção para assuntos específicos de resultados, dentro de uma organização de saúde, que devem ser motivo de revisão constante. Ao se empregar os indicadores de produtividade e qualidade relacionados à área de saúde, deve-se levar em consideração a estrutura da organização, a qualidade do material disponível e o resultado do atendimento prestado para poder mensurá-los adequadamente (SILVA *et al.*, 2006).

Os indicadores da produção podem ser agrupados em uma série de indicadores de produtividade que também se fazem preponderantes na área da saúde, na perspectiva dos negócios internos e nos vários tipos de processo de avaliação da organização em relação à concorrência — a partir desses indicadores, pode-se incorporar os melhores desempenhos de outras organizações e/ou aperfeiçoar os seus próprios métodos. Alguns desses indicadores de produtividade são:

- índice de produção por funcionário da área/subárea;
- índice de renovação ou giro de rotatividade;
- índice intervalo de substituição;
- média de permanência;
- funcionários/leitos e camas.

Indicadores de qualidade hospitalar são ferramentas de melhoria do cuidado, pois podem auxiliar na tomada de decisão clínica em relação a boas práticas e têm importância na visão dos negócios da instituição e também na perspectiva dos usuários, das autoridades administrativas e da população, já que os resultados obtidos com esses indicadores são utilizados para avaliar a qualidade resultante dos processos. Além disso, são indicadores que influenciam na escolha dos usuários por determinado hospital ou, ainda, na alocação de recursos por parte de entidades compradoras de serviços. Alguns desses indicadores hospitalares de qualidade são:

- taxa bruta de infecções;
- taxa de cesárea;
- taxa de cirurgias desnecessárias;
- taxa de complicações ou intercorrências;
- taxa de infecção hospitalar (geral/sistêmica/topográfica, respiratória, urinária, entre outros);
- taxa de mortalidade geral hospitalar;
- taxa de mortalidade institucional;
- taxa de mortalidade materna hospitalar;
- taxa de mortalidade operatória;
- taxa de mortalidade pós-operatória;
- taxa de mortalidade por anestesia;
- taxa de mortalidade transoperatória;
- taxa de remoção de tecidos normais.

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº. 1.631, de 1º de outubro de 2015 (BRASIL, 2015), aprovou critérios e parâmetros para o planejamento e programações de ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). Em seu art. 3º, aponta que os critérios e parâmetros são referenciais quantitativos utilizados para estimar as necessidades de ações e serviços de saúde e podem servir como referência para orientar os gestores do SUS em planejamento, programação, monitoramento, avaliação, controle e regulação das ações e serviços de saúde, adequando-se às realidades epidemiológicas e à disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros.

Ramos e Miyake (2010) destacam a importância de indicadores de produtividade e de qualidade e o seu crescente uso para melhoria do desempenho de serviços hospitalares. Segundo os autores, tendo em vista o

incentivo a avaliação de serviços de saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) prioriza a adoção de indicadores padronizados, que possibilitam comparações das informações no ambiente hospitalar e entre hospitais. No Quadro 1, a seguir, você confere os indicadores padronizados de produtividade hospitalar.

Quadro 1. Indicadores para avaliação hospitalar

Indicador	Abreviação	Definição
Taxa de produtividade hospitalar	$T \times PH$	$[(\text{Número de internações/ano} \times \text{Média de permanência} \times \text{Número de leitos existentes/ano}) / 365 \text{ dias}] \times 100$
Taxa de ocupação hospitalar	$T \times OH$	$(\text{Número de pacientes-dia em um período} / \text{Número de leitos-dia em um mesmo período}) \times 100$
Taxa média de permanência	$T \times MP$	$(\text{Total de pacientes-dia em um período}) / \text{Total de pacientes com alta no mesmo período}) \times 100$

Fonte: Adaptado de Ramos e Miyake (2010).

A atenção em avaliar serviços de saúde vem de longa data, mas foi na década de 1990 que ações mais efetivas surgiram, com a implementação de um método padronizado de melhorias no atendimento assistencial, para elevar o padrão de qualidade dos serviços hospitalares, o qual originou a primeira versão do Manual Brasileiro de Acreditação, que resultou na criação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) no Brasil em maio de 1999 (RAMOS; MIYAKE, 2010).

No aspecto conceitual, os indicadores de produtividade e qualidade nos serviços de saúde podem ser tratados separadamente, mas, na prática, há uma interface entre eles e ambos permitem uma visão geral do desempenho da instituição hospitalar.

O Quadro 2, a seguir, apresenta algumas propostas de indicadores de produtividade e qualidade que podem ser utilizados na área de saúde.

Quadro 2. Indicadores de produtividade e qualidade que podem ser utilizados na área de saúde

Finalidade	Equação
Estabelecer a produtividade em função da relação entre atendimento e as horas trabalhadas	$\frac{\text{Nº de consultas realizadas}}{\text{Nº de horas trabalhadas}}$
Planejar o número de leitos hospitalares e de recursos correlatos	$\frac{\text{Quantidade de recursos físicos}}{\text{Total de usuários}}$
Determinar o nível de utilização dos recursos	$\frac{\text{Nº de recursos utilizados} \times 100}{\text{Total de recursos disponíveis}}$
Determinar a qualidade dos serviços prestados em função da satisfação do usuário	$\frac{\text{Nº de pessoas satisfeitas} \times 100}{\text{Nº de pessoas atendidas}}$

Fonte: Adaptado de Damasceno, Damasceno, Barros (2008).

A partir dessas propostas, cabe, em uma muito importante próxima etapa, avaliar o custo/benefício de sua efetivação, verificando, inclusive, as informações relacionadas aos recursos necessários para sua utilização. Complementarmente, seria pertinente incluir a satisfação dos clientes/usuários para colher, na visão desses, sugestões para a melhoria de seu atendimento.

Vimos, portanto, a importância dos indicadores de saúde para a gestão e para os gestores como indicativos na tomada de decisão, bem como para compreender e visualizar o desempenho da organização de saúde. É relevante, nesse contexto, a qualificação dos indicadores, de seus atributos e a importância de seu uso para a gestão, assim como a definição dos indicadores segundo o contexto de cada organização, que deve ter metas claras e definidas para que possa fazer a escolha dos indicadores mais adequados e obter as respostas desejadas. Com relação aos indicadores de produtividade, sua escolha é mais fácil — é matemática —, mas, ao se tratar de indicadores de qualidade, tem-se envolvidos muitos conceitos abstratos cuja identificação não é tão prática.



Exemplo

A taxa de infecção é dada pela expressão matemática (pacientes infectados em determinado período / total de paciente atendidos mesmo período) $\times 100$, e o resultado revela quantas vezes o paciente adquiriu infecção durante o cuidado clínico ou internação.

Com relação a taxas de infecção hospitalar relacionada a procedimentos cirúrgicos, o maior impacto na prevenção é o simples fato de os profissionais lavarem as mãos, o que identifica o grau de comprometimento da instituição com as diretrizes de segurança (BRASIL, 2019).



Referências

ANDRADE, S. M. de. *et al.* Condições de vida e mortalidade infantil no Estado do Paraná, Brasil, 1997/2001. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 22, nº. 1, p. 181–189, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csp/2006.v22n1/181-189/>. Acesso em: 18 maio 2020.

BARBOSA, L. R.; MELO, M. R. A. da C. Relações entre qualidade da assistência de enfermagem: revisão integrativa da literatura. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 61, nº. 3, p. 366–370, maio/jun. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672008000300015&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 18 maio 2020.

BONACIM, C. A. G., ARAUJO, A. M. P. Avaliação de desempenho econômico-financeiro dos serviços de saúde: os reflexos das políticas operacionais no setor hospitalar. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 16, suppl. 1, p. 1055–1069, 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011000700038&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 18 maio 2020.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. *Controle de infecção hospitalar: balanço e reflexões*. 2019. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrxp9qY7FbU/content/controle-de-infeccao-hospitalar-balanco-e-reflexoes/219201?p_auth=5dJKaCSE&inheritRedirect=false. Acesso em: 18 maio 2020.

BRASIL. Portaria nº. 1.631, de 1º de outubro de 2015. Aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. *Diário Oficial da União*, Brasília, 1 out. 2015. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1631_01_10_2015.html. Acesso em: 18 maio 2020.

DAMASCENO, H. E. M.; DAMASCENO, A. R. G.; BARROS, J. G. M. de. Indicadores de qualidade e produtividade na área da saúde. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 12., 2008, São José dos Campos. *Anais eletrônicos* [...]. Disponível em: http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2008/anais/arquivos/EPG/EPG00715_01_O.pdf. Acesso em: 18 maio 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Taxa de mortalidade infantil*. [2018]. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/pesquisa/39/0?localidade1=0&tipo=grafico&indicador=30279>. Acesso em: 18 maio 2020.

MARTINS, P. C. R.; PONTES, E. R. J. C.; HIGA, L. T. Convergência entre as taxas de mortalidade infantil e os índices de desenvolvimento humano no Brasil no período de 2000 a 2010. *Interações*, v. 19, nº. 2, p. 291–303, 2018. Disponível em: <https://www.interacoes.uccb.br/interacoes/article/view/1552>. Acesso em: 24 maio 2020.

MERCHÁN-HAMANN, E. M.; TAUILL, P. L.; COSTA, M. P. Terminologia das medidas e indicadores em epidemiologia: subsídios para uma possível padronização da nomenclatura. *Informe Epidemiológico*, v. 9, nº. 4, p. 273–284, 2000.

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 2. ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. *Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de Enfermidades*. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (E-book).

RAMOS, A. W.; MIYAKE, D. I. Desenvolvendo indicadores de produtividade e qualidade em hospitais: uma proposta de método. *Produto & Produção*, v. 11, nº. 2, p. 67–84, jun. 2010. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/ProdutoProducao/article/download/7517/8250>. Acesso em: 24 maio 2020.

ROCHA, E. S. B.; TREVIZAN, M. A. Gerenciamento da qualidade em um serviço de enfermagem hospitalar. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 17, nº. 2, mar./abr. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rlae/v17n2/pt_16.pdf. Acesso em: 24 maio 2020.

ROSSANEIS, M. A. *et al.* Indicadores de qualidade da assistência: opinião de enfermeiros gerentes de hospitais de ensino. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, v. 16, nº. 4, p. 798–804, out./dez. 2014. Disponível em: <https://revistas.ufrpr.br/cogitare/article/download/41734/26785>. Acesso em: 24 maio 2020.

SILVA, M. A. da. *et al.* *Complexidade e sistema de enfermagem hospitalar*. 2006. 214 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) — Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/88375/235296.pdf?jsessionid=772CBEF3AE5268AD99FDE5FF69BE3660?sequence=1>. Acesso em: 24 maio 2020.

TANAKA, O. Y.; TAMAKI, E. M. O papel da avaliação para a tomada de decisão na gestão de serviços de saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, nº. 4, p. 821–828, abr. 2012. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000400002&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 24 maio 2020.

**Fique atento**

Os *links* para *sites da web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS